



1

Stuhlinkontinenz

CE 02/ UE 04 Ausscheiden

Definition

Unfähigkeit, den Stuhl kontrolliert zurückzuhalten. Verschiedene Ursachen sind vorhanden:

- ❖ (Angeborene) neurologische Ursachen
- ❖ Hämorrhoiden (fehlende Wahrnehmung)
- ❖ Schließmuskel: Verletzungen, Tumore
- ❖ Operationen am Enddarm
- ❖ Psychische Faktoren (z.B. Demenz, Trauma)

Pflegerische Anamnese

- Beschaffenheit des Stuhls (Konsistenz)
- Vorerkrankungen und Medikamente
- Beeinträchtigung Lebensqualität
- Ärztliche Diagnostik (z.B. Beurteilung analer Schließfähigkeit, Differenzialdiagnosen)
- Stuhldiagnostik (V.a. Infekte)

Erste Anzeichen



- Häufiger oder plötzlicher Stuhldrang
- Rötungen oder Hautreizungen im Analbereich
- Wunsch, Bettwäsche selbst zu wechseln
- Heimliches Entsorgen von Kleidung
- Vermeidung sozialer Kontakte oder Rückzug
- Wiederholtes Duschen oder Kleiderwechsel ohne ersichtlichen Grund

Risikofaktoren

Überlastung Beckenboden (z.B. Adipositas, Schwangerschaft)

Höheres Alter und/oder Pflegebedürftigkeit

Ungünstige Gewohnheiten (z.B. Drang unterdrücken)

Bestrahlungen

Kognitive Einschränkungen

Neurologische Erkrankungen (z.B. M. Parkinson)

Diarrhoen

Folgen sexualisierter Gewalt

Erkrankungen Verdauungstrakt (z.B. M. Crohn)

Schweregrade

Grad 1: leichte Form, mit gelegentlichem Abgang von Gasen oder etwas Stuhl, insbesondere bei Durchfall oder körperlicher Anstrengung → Die Unterwäsche bleibt meist sauber oder ist nur leicht verschmutzt

Grad 2: mittlere Ausprägung mit unkontrolliertem Verlust von flüssigem Stuhl und häufig verschmutzter Kleidung

Grad 3: schwere Form, bei der der Stuhlgang und Gase vollständig unkontrolliert abgehen – eine vollständige Inkontinenz

Tab. 13.1 Revised Fecal Incontinence Scale (RFIS) mit 5 Fragen (Quelle: [13]). Ein Score von 4–6 Punkten entspricht einer leichten (milden), ein Score von 7–12 Punkten einer moderaten und ein Score > 12 Punkten einer schweren Inkontinenz. Eine Verminderung um 4 Punkte entspricht einer klinisch relevanten Verbesserung der Inkontinenz.

Inkontinenz-Typ	nie	selten (< 1/letzten 4 Wochen)	manchmal (< 1/letzte Woche, > 1/letzten 4 Wochen)	oft (< 1/Tag, > 1/Woche)	immer (> 1/Tag, bei jedem Stuhlgang)
Verlieren Sie Stuhl, haben Sie Inkontinenz-Zwischenfälle oder verlieren Sie festen Stuhl?	0	1	2	3	4
Verlieren Sie Stuhl, haben Sie Inkontinenz-Zwischenfälle oder verlieren Sie flüssigen Stuhl?	0	1	2	3	4
Verlieren Sie Stuhl, wenn Sie nicht rechtzeitig eine Toilette finden?	0	1	2	3	4
Verlieren Sie Stuhl, sodass Sie die Unterwäsche wechseln müssen?	0	1	2	3	4
Belastet der unfreiwillige Stuhlabgang Ihre Lebensumstände (Lifestyle)?	0	1	2	3	4

Cleveland Clinic Incontinence Score

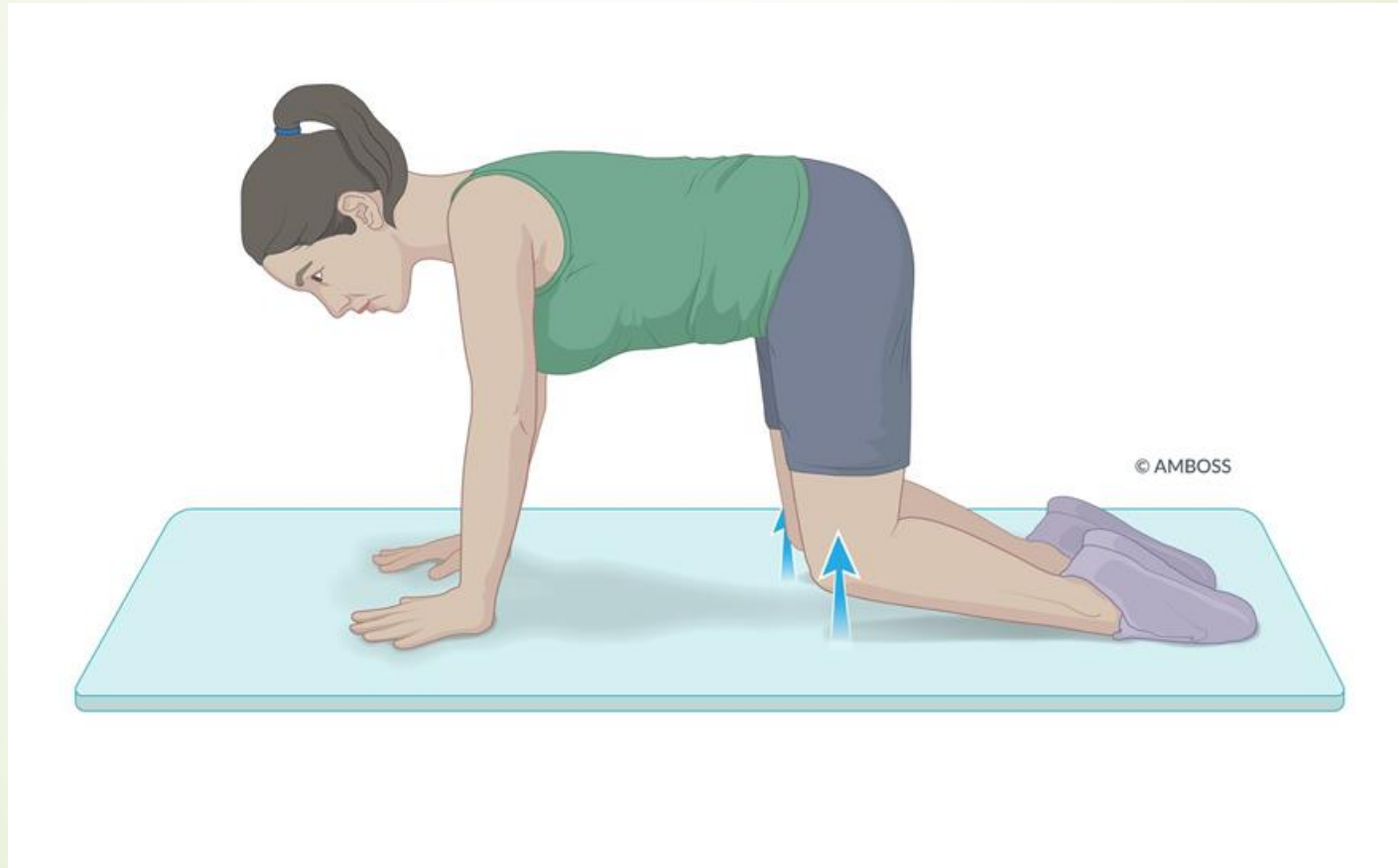
- Perfekte Kontinenz = 0 Punkte
- gute Kontinenz = 1-7 Punkte
- moderate Inkontinenz = 8-14 Punkte
- schwere Inkontinenz = 15-20 Punkte
- totale Inkontinenz = 21 Punkte

	Gas (Blähungen)	Flüssiger Stuhl	Fester Stuhl	Vorlagenwechsel
Gelegentlich	1	4	7	1
Mehr als 1x/ Woche	2	5	8	2
Täglich	3	6	9	3

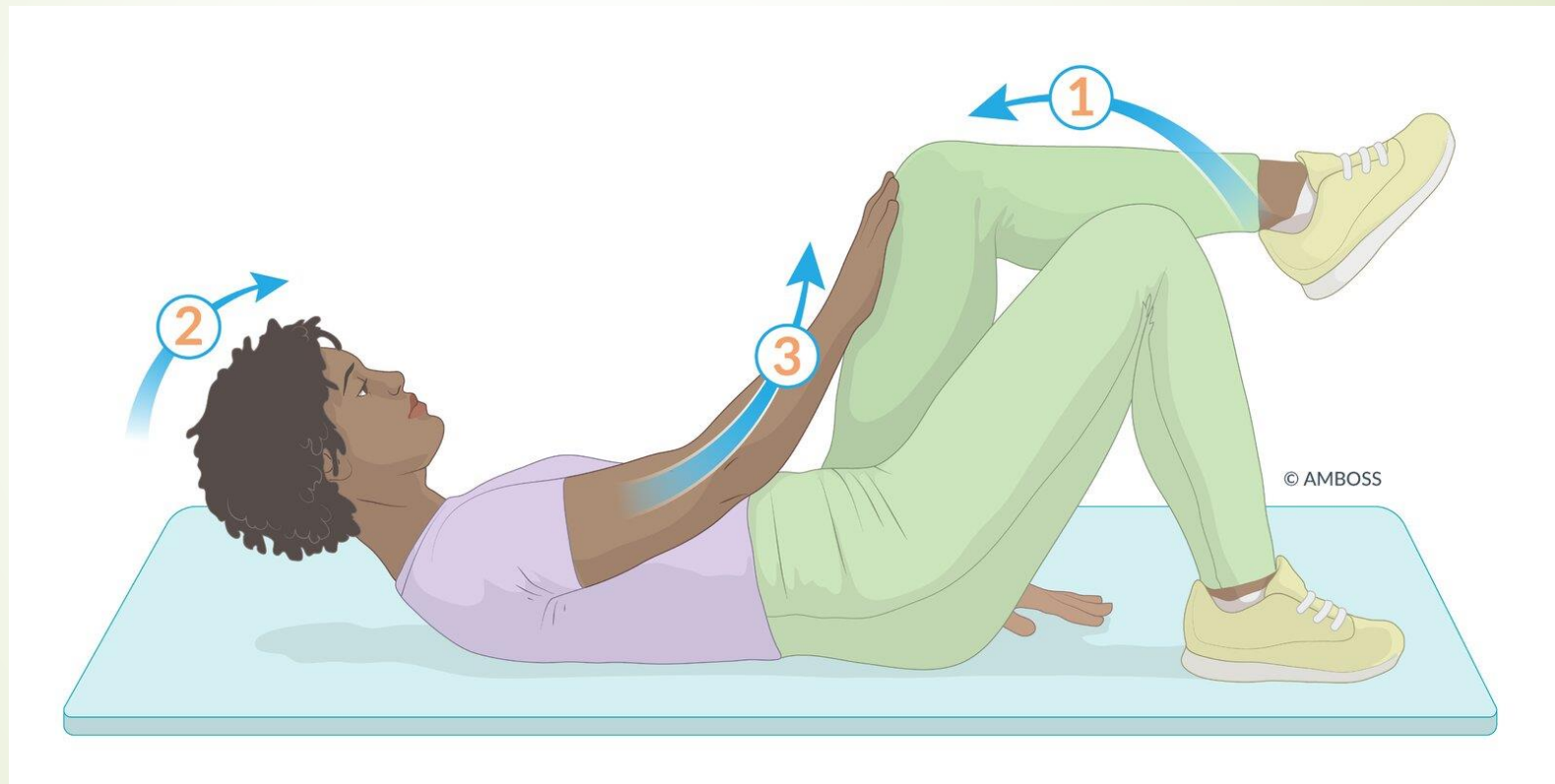
Maßnahmenplan I

- Beckenbodentraining

Übung 1: Vierfüßlerstand



Übung 2: Knie in Rückenlage andrücken



Maßnahmenplan II

- Stuhlkonsistenz verbessern (z.B. durch Ernährung)
- Medikamentöse Reduktion der Peristaltik (z.B. Loperamid/ Imodium)
- Darmentleerungstraining (festgelegte Zeiten einhalten)
- Generell: Privatsphäre beachten, ausreichend Zeit, Kolonmassage zur verbesserten Defäkation
- Gezieltes Darmmanagement (zur gleichen Zeit nach ä.A. Klistier/ Zäpfchen)

Maßnahmenplan III

- Nutzung von aufsaugenden Hilfsmitteln (Schutzhose, Einlage)
- Nutzung von Hilfsmitteln



Fäkalkollektor (1-2 Tage)



Stuhl drainagesystem
(bis zu 30 Tage)

Professioneller Umgang

- Wahrung der Intimsphäre
- Respektvoller, würdevoller Umgang auf Augenhöhe
- Gefühle wahrnehmen und Grenzen wahren
- „Windel“, „Popo“ o.Ä. vermeiden!